

GUÍA PRÁCTICA DETALLADA

Atención a las mujeres sometidas a violencia: un plan de estudios de la OMS para la formación de profesionales de la salud

WHO · English · 2019

importante: Esta es una guía de lectura no oficial detallada, no una traducción oficial. Consulte la publicación original para conocer todos los requisitos y el contexto.

Basado en la publicación original.

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/330084/9789241517102-eng.pdf>

Contenidos

1. Objeto y alcance
2. Orientación clave
3. Cómo utilizar esta guía
4. Principios centrados en el superviviente
5. Secuencia de respuesta práctica
6. Controles de seguridad y calidad.
7. Lista de verificación de acciones

01 Objeto y alcance

- Una guía de capacitación para proveedores de atención médica sobre cómo reconocer la violencia, ofrecer apoyo de primera línea, brindar atención clínica y conectar a las mujeres con servicios seguros.

02 Orientación clave

- Crear condiciones de consulta privada y nunca preguntar sobre violencia cuando esté presente una pareja, un familiar o un intérprete elegido por la pareja.
- Utilice soporte de primera línea: escuche atentamente, pregunte sobre las necesidades, valide, mejore la seguridad y conéctese con soporte.
- Preguntar sólo cuando sea clínicamente relevante y cuando exista una vía de respuesta segura; Los interrogatorios rutinarios sin capacidad de respuesta pueden causar daño.
- Evaluar el peligro inmediato, las amenazas, las armas, el acecho, el estrangulamiento, la escalada de violencia y las amenazas que involucran a niños.
- Tratar las lesiones y las consecuencias para la salud sin que la denuncia policial sea una condición de atención.
- Documentar de forma objetiva, segura y con consentimiento; distinguir las observaciones de las acusaciones y evitar el lenguaje crítico.
- Explique los límites de confidencialidad y obligación de informar antes de la divulgación, incluidas las reglas especiales que afectan a niños o personas incapaces.
- Practique mediante juegos de roles supervisados, ejercicios de reflexión y referencia; Las actitudes y los prejuicios de los proveedores afectan directamente la calidad de la atención.

03 Cómo utilizar esta guía

- Esta guía convierte la publicación original en una ayuda práctica para la lectura. Está diseñado para sobrevivientes, partidarios de confianza, personal de servicios sociales y de salud y gerentes de programas. No reemplaza los servicios de emergencia, la atención médica, el asesoramiento legal ni la publicación fuente completa.
- Utilice sólo las piezas que se ajusten a la situación de la persona. Preservar su elección, privacidad y ritmo. Si una acción sugerida podría exponer la navegación, las llamadas, los documentos o la ubicación a una persona abusiva, primero elija un dispositivo, lugar o momento más seguro.

Principios centrados en el superviviente

- La seguridad es lo primero. Pregunte qué haría que las próximas horas o días fueran más seguros y evite medidas que puedan provocar represalias. Nunca solicite una divulgación para ofrecer ayuda básica.
- Respetar la autonomía y el consentimiento informado. Explicar opciones realistas, beneficios, límites y posibles riesgos; el superviviente decide lo que sucede a continuación, a menos que se aplique un deber legal de protección inmediato.
- Proteger la confidencialidad. Recopile la información mínima, restrinja el acceso, acuerde métodos de contacto seguros y explique cualquier límite antes de compartir información.
- Proporcionar acceso equitativo. Considere la discapacidad, el idioma, la edad, la situación migratoria, la pobreza, el aislamiento rural, la orientación sexual y otras barreras sin estereotipos.

Secuencia de respuesta práctica

- Comience con las necesidades inmediatas de seguridad y salud urgentes. Pregunte en privado, sin la presencia del presunto agresor, si es seguro hablar y si la persona necesita atención de emergencia.
- Escuche sin interrogar. Validar lo sucedido, evitar culpas y no exigir un relato o prueba cronológica. Registre sólo lo que sea necesario y utilice las propias palabras del sobreviviente.
- Ofrecer un pequeño número de opciones verificadas: atención médica, alojamiento seguro, apoyo psicosocial, información jurídica, policía o servicios de protección cuando corresponda. Explique que aceptar un servicio no requiere aceptar todos los demás.
- Haga una referencia cálida cuando se dé el consentimiento: confirme que el servicio esté abierto, accesible y seguro; explique qué esperar; y evitar enviar al sobreviviente repetidamente entre agencias.
- Acuerde el seguimiento y una forma segura de comunicarse. No deje mensajes de identificación, envíe notificaciones reveladoras ni almacene archivos con nombres obvios si los dispositivos pueden ser monitoreados.

06

Controles de seguridad y calidad.

- No confronte al presunto perpetrador, no medie en una relación violenta, no prometa un resultado que no pueda controlar ni presione a un sobreviviente para que se vaya de inmediato.
- No utilice números de teléfono ni referencias no verificadas. Los servicios pueden cerrarse, cambiar las reglas de elegibilidad o compartir información de manera insegura; Confirme los detalles antes de la publicación o referencia.
- Las organizaciones deben capacitar al personal, supervisar los casos difíciles, crear reglas de documentación confidencial, mantener mapas de referencia actualizados y ofrecer apoyo al personal para reducir el agotamiento y las prácticas nocivas.

07

Lista de verificación de acciones

- ¿Es seguro hablar, leer o conservar este documento ahora mismo?
- ¿Se han considerado las lesiones urgentes, las preocupaciones sobre el embarazo, la atención por violencia sexual y el riesgo de suicidio?
- ¿Ha elegido el sobreviviente qué información puede registrarse o compartirse?
- ¿Se abordan las barreras de interpretación, acceso para discapacitados, cuidado infantil, transporte y costos?
- ¿Se verifican las referencias y existe un plan de seguimiento seguro?
- ¿Le han dicho a la persona que la violencia no es culpa suya y que puede rechazar cualquier opción?